

Rapport de la Situation Maladie à Virus Ebola

Sitrep MVE N° 008/MVE_16/2025

Pays/Province

: RDC / Kasai

Zone de santé

: BULAPE, MWEKA et MUSHENGE

Date de rapportage

: 12 Sept 2025

Période couverte

: 01 – 11 Sept 2025

Date de publication

: 14 Sept 2025

						
43	30	27	16	12/18	350	60
Cas Suspects	Cas confirmés	Total Décès	Cas confirmés DCD Létalité = 53,3%	Taux d'occupation des lits = 66,6%	Nombre de doses de vaccin déployées	Nombre de personnes vaccinés (prestataires de Kinshasa)

I. POINTS SAILLANTS

- 3 nouveaux cas suspects ont été notifiés dans la Zone de Santé (ZS) de Bulape.
- 5 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés dans la même zone.
- 2 nouveaux décès liés à des cas confirmés ont été rapportés à Bulape.
- Déploiement de 350 doses de vaccins effectué à Bulape, sur les 4 180 doses disponibles au niveau central.
- Une alerte concernant un ressortissant chinois à Tshikapa : résultats également négatifs.
- Une alerte extra-provinciale signalée : 1 alerte à Kinshasa, en provenance d'Ilebo (résultats négatifs).
- Arrivée de l'IM et de son équipe à Bulape pour renforcer les activités de riposte.

Tableau 1. Situation journalière des alertes et investigation

INDICATEURS	12/09/2025	11/09/2025
Nouvelles alertes signalées du jour	8	6
Report alertes:	0	0
Total alertes du jour	8	6
Alertes investiguées du jour	6	6
Alertes Validées du jour	6	2
Transférées au CTE	6	1
Nouveaux cas suspects prélevés	2	1

Tableau 2. Récapitulatif des cas suspects, cas confirmés, non cas et décès par zone de santé au 12 septembre 2025

ZONE DE SANTE	Cas suspect au			Cas confirmés		Non cas		Décès			
	Cumul cas suspect au 12/09	Nouveau cas suspect	Total cas suspects	Nouveaux confirmés	Total confirmés	Nouveaux non cas	Total non cas	Nouveaux décès parmi les confirmés	Total décès parmi les confirmés	Nouveaux décès parmi les non cas	Total décès parmi les non cas
BULAPE	40	3	43	5	30	2	13	2	16	0	0
MWEKA	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	1
KAKENGE	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
MUSHENGA	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0
TOTAL	40	3	43	5	30	6	27	2	16	0	1

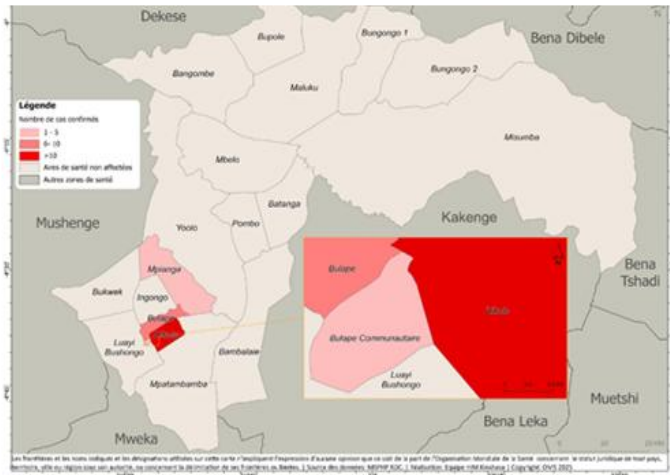


Fig1.Répartition géographique des cas confirmés par Aire de santé de la ZS de Bulape

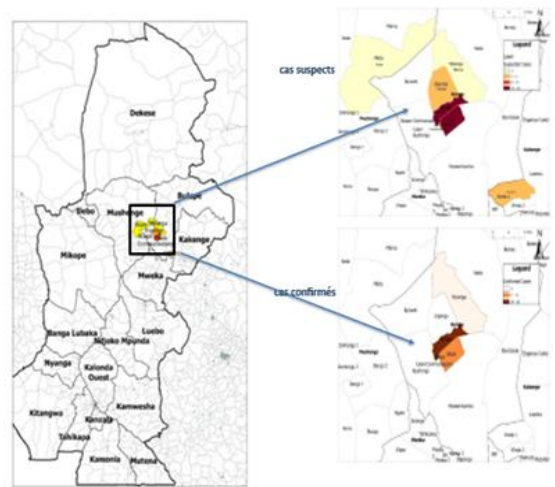


Fig2 Spatialisation des cas suspects et confirmés par AS dans la ZS de Bulape

Tableau 3. Suivi des contacts

Province	Zone de santé	Contacts à suivre	Contacts suivis	Taux de suivi de contact	Contacts non vus	Contacts devenus suspects	Sorties du suivi après 21 jours	Nouveaux contacts du jour	Contacts à reporter
Kasaï	Bulape	654	591	90,3%	56	5	0	58	712
Total		652	591	90,3%	56	5	0	58	712

Tableau 4. Raisons de non suivi des contacts

Contacts non vus		56
Absence simple	3	
Reco n'est pas passé	52	
Perdus de vue	0	
Jamais vus	0	
Déplacés	1	(Kananga)

II. REPONSE EN COURS

COORDINATION

- 2^{ème} réunion stratégique SGI National MVE
- Briefing des membres SGI sur le plan de réponse Ebola
- Briefing des superviseurs provinciales sur la vaccination
- Réunion du conseil de sécurité avec les APA et l'église protestante et le chef de groupement/SGI Bulape

SURVEILLANCE

- Approfondissement des investigations avec Listage de 98 nouveaux contacts
- Briefing des équipes de surveillance (14 superviseurs de la ZS dont 3 IT des AS les plus touchées et 3 superviseurs de la DPS sur l'investigation et l'élaboration des parcours communautaires et thérapeutiques des 19 cas confirmés
- Participation à la réunion préparatoire de la vaccination contre la MVE

LABORATOIRE

- Au total, 18 échantillons ont été collectés ce jour, dont 13 nouveaux prélèvements et 5 cas suspects.
- Parmi eux, 12 ont déjà été analysés : 7 provenant de Bulape et 5 de la zone de santé de Dekese.
- Il reste 6 échantillons en attente d'analyse : 1 en provenance d'Ilebo et 5 prélèvements de Bulape.
- Les 12 résultats disponibles révèlent 5 cas positifs et 2 négatifs à Bulape, ainsi que 5 résultats négatifs à Dekese

PRISE EN CHARGE MÉDICALE, NUTRITIONNELLE et PSYCHOSOCIALE

- Capacité du CTE : 18 lits répartis dans 2 pavillons (homme et femme)
- Douze (12) malades au lit.
- 1 décès d'un enfant de sexe M de 7 ans dans un tableau de détresse respiratoire
- Appui alimentaire en faveur des patients hospitalisés au CTE.
- Suivi médical des malades pris en charge au sein du CTE selon les protocoles standards.
- Évaluation clinique régulière des patients hospitalisés au CTE.
- L'OMS a fait bénéficier 477 personnes d'un soutien psychologique et des évaluations de l'état mental malades Mpox dans les DPS Kinshasa (50), Sud-Ubangi (5), Nord Kivu (71) et Sud Kivu (302 dont 63 PPL et 4 enfants vulnérables)

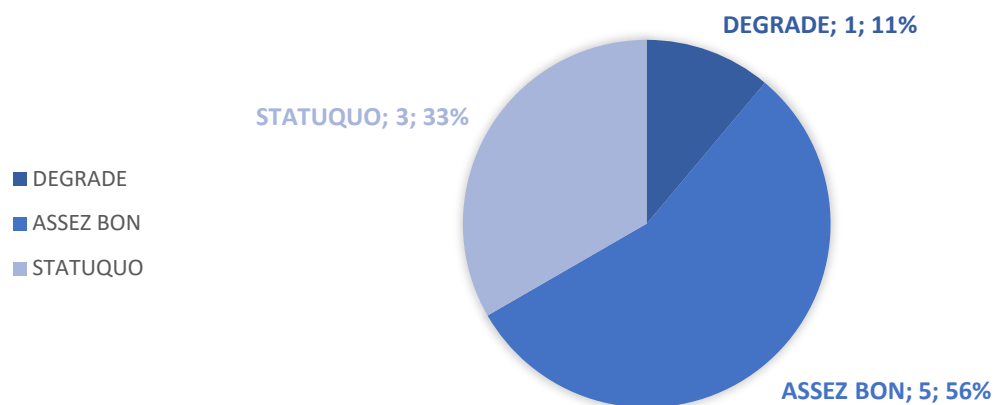


Figure: evolution des malades au CTE (n=12)

PCI WASH

- Briefing de 15 prestataires de l'HGR des soins dont 6 F et 9, Briefing de 20 hygiénistes et 20 fossoyeurs sur les généralités sur la MVE et la PCI clinique
- Décontamination des 6 ménages des cas confirmés décédés récemment
- Evaluation score card à l'HGR avec 9% et Bulape communautaire 8,3%

COMMUNICATION SUR LES RISQUES ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

- Diffusion des dépliants d'information.
- Appui au dispositif de surveillance pour l'identification et le suivi des contacts.
- Poursuite de la formation des relais communautaires dans trois aires de santé : Dikolo, Bulape et Bulape Communautaire.
- Planification de sessions de formation dans cinq nouvelles aires de santé

LOGISTIQUE

- Réception de 350 doses de vaccins, de 11 registres de vaccination et de 1 200 cartes vaccinales.
- Appui aux activités de vaccination de routine (EDS) au centre de santé de Bambalaie.
- Vols d'essai effectués par hélicoptère sur l'itinéraire Kananga – Tshikapa – Bulape.
- Poursuite des travaux d'aménagement des sites d'hébergement.
- Suivi de l'avancement des travaux de construction des infrastructures de pré triage et de triage au sein du CTE

SECURITE

- Monitoring sécuritaire quotidien .

III. DEFIS

1. SURVEILLANCE

- Insuffisance des outils de collecte
- Faible capacité de mobilité pour mener les interventions
- Insuffisance des thermo flash et des piles pour les diverses activités

2. COMMUNICATION

- Insuffisance des piles et Mégaphones
- Manque de supports de communication

3. PRISE EN CHARGE MÉDICALE, NUTRITIONNELLE et PSYCHOSOCIALE

- Refus des prestataires de l'HGR à travailler dans le CTE
- Manque de médicaments pour la réanimation
- Besoin urgent des prestataires expérimentés
- Absence de prise en charge psychosociale
- Manque d'ambulance

- Absence d'un CTE normé

4. PCI/WASH

- Faible approvisionnement en eau au CTE.

5. LOGISTIQUE

- Manque d'ambulance pour le transport des malades
 - La mobilité des équipes de réponse est insuffisante ;
 - Insuffisance de la chaîne de froid appropriée pour les vaccins
-
- Récupérer le cas confirmé de l'AS Bambalayi avec une charge virale très élevée
 - Décontaminer le CS Bambalayi
 - Approfondir les investigations et lister tous les contacts
 - Appui des APA pour convaincre 8 cas suspects à rejoindre le CTE
 - Superviser toutes les réunions des différents piliers d'où il faut que les piliers partagent les lieux des réunions et l'heure
 - Dotation des motos à la ZS Bulape pour appui aux opérations de terrain



Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter :

Pour l'Institut National de la Santé Publique (INSP) de la RDC

Le Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

Tel. : +243 816 040 145

E-mail : dieudonnmwambakazadi@gmail.com

Le Coordonnateur COU-SP

Prof NGANDU Christian

Tél. : +243998091915

E-mail : nganduchristian@ymail.com

L'Incident Manager SGI MVE Epi16

Dr. KITENGE OMASUMBU Richard

Richard.kitenge@insp.cd

Pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Le Représentant de l'OMS en RDC :

Dr Nikiema Jean Baptist

E-mail : nikiemaje@who.int

Incident Manager de l'OMS dans la réponse MVE:

Dr Mory Keita

E-mail : mokeita@who.int

Le Team Lead Cluster EPR de l'OMS en RDC :

Dr Mouctar Diallo

E-mail : dialloam@who.int